



COMPTE-RENDU D'EXAMEN ECHOCARDIOGRAPHIQUE

PROPRIETAIRE : KEIB

PATIENT : SPIKE

DATE : 18/06/2026

Commémoratifs :

- Antécédents: suivi de sténose sous-aortique de stade B2
- Signes cliniques: aucun. FR 20-25 au repos
- Auscultation cardio-respiratoire: souffle systolique apexien gauche 3/6
- Traitement cardiaque en cours: benefortin 2.5mg/j xarelto 2.5mg/j
- Qualité de l'examen: correcte sur chat légèrement agité

Interprétation:

Les coupes Temps-Mouvement transventriculaire et transmitrale obtenues par voie parasternale droite montrent:

- **Un septum interventriculaire d'épaisseur augmentée (>6mm), de manière diffuse (en diastole)**
- **Une paroi libre du ventricule gauche d'épaisseur normale (<5mm) (en diastole)**
- **Des muscles papillaires modérément hypertrophiés**
- **Une cinétique ventriculaire dans les normes**
- Un ventricule droit dans les normes

Les coupes 2D quatre cavités obtenues par voies parasternales droite et gauche montrent:

- L'absence de régurgitation mitrale
- Un flux mitral normal (E/A)
- L'absence de régurgitation tricuspideenne
- **Une oreillette droite de taille augmentée (valeurs stables)**
- L'absence de communication interventriculaire
- L'absence de communication interatriale

Les coupes 2D cinq cavités obtenues par voies parasternales droite et gauche montrent:

- **Un flux transaortique non laminaire en regard du bourrelet septal, mais de vélocité correcte et stable (Vmax 1.69m/s)**
- L'absence d'insuffisance aortique
- **La présence d'un mouvement systolique antérieur du feuillet septal de la valve mitrale (SAM)**

Les coupes 2D transaortique et transpulmonaire obtenues par voie parasternale droite montrent:

- **Un atrium gauche de diamètre augmenté (valeurs stables)**
- Un tronc pulmonaire normal
- **Un flux transpulmonaire non laminaire et de vitesse légèrement augmentée (stress)**
- L'absence d'insuffisance pulmonaire



- L'absence d'une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule droit (DRVOTO)

Autres observations:

- Absence d'épanchement pleural
- Absence d'épanchement péricardique
- **Echogénicité du myocarde anormale avec un endocarde hyperéchogène et irrégulier**
- **Absence de thrombus intracavitaire / de volutes préthrombotiques**

Conclusion

- **Sténose sous-aortique équivalent à une cardiomyopathie de phénotype hypertrophique essentiellement septale, non obstructive avec dilatation biatriale stable.**
- **Absence de trouble du rythme ce jour**
- **Stade ACVIM B2**

A: chats prédisposés à une cardiomyopathie mais sans signe de la maladie

B1: cardiomyopathie présente mais sans signe clinique, risque faible d'insuffisance cardiaque congestive imminente ou de thrombo-embolie artérielle. Dilatation légère à modérée de l'AG

B2: cardiomyopathie présente mais sans signe clinique, risque plus élevé d'insuffisance cardiaque congestive imminente ou de thrombo-embolie artérielle. Dilatation modérée à sévère de l'AG

C: chats qui ont développé une insuffisance cardiaque congestive ou une thrombo-embolie artérielle, même si les signes cliniques ne sont plus présents avec un traitement

D: chats avec une insuffisance cardiaque congestive réfractaire au traitement.

- **A ce stade, le traitement est conservé à posologie identique**

Contrôle:

- **Contrôle échographique dans 10-12 mois en l'absence de difficulté respiratoire ou locomotrice**
- **Il est conseillé aux propriétaires de surveiller la fréquence respiratoire au repos (< 30 par minute)**

Dr Nathalie PALHA-ROHR